

文献综述：B 站健康科普视频中的视觉标题党、图文代表性与差异化用户参与

Generated by /scholar-lit-review on 2026-05-24

写作模式：中文约 6000 字；面向假设检验式论文的 *Literature Review / Hypothesis Development*

本地材料：clickbait_paper/参考文献；网络补充检索：2026-05-24

一、问题提出：为什么健康科普视频不能只研究“点击”

短视频平台已经成为公众接触医学与健康知识的重要入口。与传统健康传播不同，平台环境中的健康信息首先不是以完整论证、指南或问答的形式被用户接触，而是以标题、封面缩略图、UP 主身份、播放量、点赞量和弹幕氛围等入口线索被用户快速判断。在 B 站场景中，健康科普视频的入口尤其具有多模态特征：用户在点击前通常同时看到标题、缩略图、UP 主名称、播放量和弹幕/互动提示。因此，所谓“视觉标题党”不只是把文字标题写得夸张，也包括通过病灶图、惊恐表情、红圈箭头、前后对比、白大褂、检查报告、大字警告和悬念式构图等视觉手段制造注意力压力。

本研究关心的核心现象是：健康科普内容的传播成功可能同时包含两套逻辑。一套是注意力逻辑，即哪些标题和缩略图让用户停下、点击、点赞；另一套是信任与实用价值逻辑，即哪些内容让用户愿意收藏、投币、分享，或者在弹幕中提出求证、纠错和经验补充。现有健康视频质量研究不断显示，视频质量、可靠性和用户参与度之间并不总是一致。部分 Bilibili/TikTok 健康视频研究发现，医生、医疗机构或非营利组织提供的内容质量较高，但互动表现未必最高；也有研究发现，在某些疾病主题中，B 站视频质量较高或更完整，却不一定获得更强的平台参与（Han et al. 2026；Zhang et al. 2025；Wang et al. 2025）。这说明“被看见”不等于“被认可”，更不等于“值得依据其采取健康行动”。

因此，本文综述的目标不是泛泛讨论健康传播，也不是重新证明标题党能带来点击，而是为一个假设检验式研究建立理论链条：在 B 站健康科普视频中，视觉标题党和图文代表性如何影响不同成本的用户参与行为？具体而言，本文把 play 和 like 视为低成本参与，把 danmaku 视为互动性与解释性参与，把 coin、favorites 和 share 视为更高成本、更接近认可、实用价值或传播意愿的参与。这样的拆分有助于避免把所有 engagement 混为同一种结果变量。

二、概念界定：视觉标题党、图文代表性与差异化参与

点击诱饵研究通常从信息缺口出发。Loewenstein 的好奇心理论认为，当个体意识到已知与未知之间存在缺口时，会产生补全信息的动机。后续新闻标题研究将这一机制转化为“标题有意保留关键信息”的写作策略。Scott（2021）和近期有关 curiosity gap 的研究均强调，标题党并不只是夸张，而是通过省略、暗示、悬念或未完成叙事推动用户点击。Deng 等（2025）在健康传播语境中进一步指出，健康 clickbait 的核心特征可以理解为信息缺口和情绪强度：前者激发好奇与错失恐惧，促进点击；后者可能引发对他人评价的担忧，从而抑制分享。这一发现对本研究很关键，因为健康内容的点击诱饵不是纯娱乐化策略，它直接关联疾病、风险和个人后果。

然而，B 站健康科普视频中的标题党不应局限于标题文本。Al-Ali 和 Hamzeh (2024) 对 YouTube 阿语标题党缩略图的多模态分析表明，视频缩略图中的文字、图像、表情、标点和构图共同构成诱导点击的意义系统。Wang 等 (2025) 把 clickbait 分为 hyperbole、insinuation、visual rhetoric 和 puzzle 等类型，并用 EEG 研究显示，不同类型对注意和情绪加工的作用并不相同。这提示我们，在视频平台研究中，视觉修辞本身就是点击诱饵的一部分，而不是标题的附属物。

本文将“视觉标题党”定义为：缩略图通过视觉或图文组合线索制造强烈注意、悬念、风险、权威或情绪压力，以提高用户进入视频的可能性，但其视觉承诺可能与视频实际内容或标题承诺存在不充分代表、夸张或误导关系。这个定义有两个重点。第一，视觉标题党不必然等于虚假信息；它可以只是强诱导式呈现。第二，视觉标题党的理论风险在于“代表性”：缩略图到底是在准确概括视频内容，还是在利用局部、极端或不完整的视觉线索制造点击理由。

因此，“图文代表性”成为本文的核心桥梁。Li 和 Xie (2020) 在品牌社交媒体研究中发现，图片本身、图片质量、人脸和图文匹配都可能影响参与。Cao、Li 和 Zhang (2025) 则进一步指出，图文一致性与用户偏好可能不是简单线性关系；高一致性可以带来流畅性，低一致性也可能通过意外感诱发进一步加工，而中等一致性反而缺少鲜明优势。Yoon 等 (2024) 和相关 CLIP 研究则把缩略图代表性转化为可计算问题，关注图像是否能真实代表文本内容。放到健康科普语境中，图文代表性不只是营销效果问题，而是健康信息是否被正确预期、是否被信任、是否被保存的前置条件。

最后，B 站的参与行为也需要概念拆分。播放和点赞成本低，可能更多反映注意力和即时好感；弹幕需要用户表达，可承载情绪、质疑、求证、纠错和社群仪式；收藏意味着内容有未来再查阅价值；投币受到平台机制和用户预算约束，更接近对创作者或内容价值的高成本认可；分享则意味着用户愿意把内容推荐给外部或他人。Dong 等 (2025) 关于 danmaku ritual 的研究也提示，弹幕不是单一“评论数”，不同类型弹幕对应不同的社会情绪、群体认同和数字参与。由此，本研究不应只预测单一播放量，而应建立多结果变量模型。

三、健康科普视频质量研究：质量与传播之间的脱钩

近年来，大量研究开始评估 TikTok、Bilibili、YouTube、Kwai、Douyin 等平台上的健康视频质量。这类研究通常使用 DISCERN、mDISCERN、JAMA Benchmark、Global Quality Score、PEMAT、VIQI 等工具，从准确性、完整性、可理解性、可操作性和来源透明度等方面评估健康信息。主题覆盖体重管理、宫颈癌、尿毒症、心肌梗死、骨关节炎、食管癌、前列腺癌、肌少症、川崎病、卒中、脊髓损伤等。虽然不同疾病主题和平台的结果并不完全一致，但一个共同发现是：健康视频平台上的内容质量参差不齐，来源类型、视频形式和平台机制都会影响质量与传播表现。

以体重管理视频为例，Han 等 (2026) 比较 TikTok 与 Bilibili 后发现，B 站视频总体参与指标低于 TikTok，但质量和可靠性得分更高；同时，医生和非营利组织内容质量较好，而个人用户内容质量较弱。该研究还指出，点赞、分享、评论和收藏等参与指标与质量/可靠性得分呈负相关，说明流行度不能直接当作科学可靠性的替代指标。食管癌短视频研究也显示，Bilibili、TikTok 和 Kwai 在视频质量、完整性和参与模式上存在平台差异；其中 B 站内容质量较高但 engagement score 较低，而收藏与质量分数在 B 站上存在更有解释力的关系 (BMC Public Health 2025)。这些发现把“质量-传播脱钩”推到研究中心。

但这一文献也有明显局限。第一，多数研究把用户参与作为并列指标处理，较少理论化不同

参与行为的成本差异。点赞、评论、收藏、分享经常被放入同一个 engagement score，但用户做出这些行为的心理含义并不相同。第二，健康视频质量研究通常关注完整视频内容、上传者身份和医学质量，而不是用户点击前看到的缩略图和标题入口。第三，这类研究多为横截面描述或相关分析，贡献在于证明平台健康信息质量不稳定，但较少解释为什么某些低质量或中等质量内容能够获得较高可见度。

因此，本研究的切入点不是替代健康视频质量评估，而是在其基础上解释“入口视觉线索”如何影响不同类型参与。如果一个健康视频通过夸张缩略图获得播放，却没有获得收藏或投币，那么它的传播效果应被理解为注意力成功而不是健康传播成功。相反，如果图文代表性高、来源清楚、视觉信息具体的内容不一定获得最高播放，却更容易获得收藏、投币或建设性弹幕，那么这说明平台参与行为内部存在质量信号。

四、视觉健康传播：图像不是装饰，而是风险、可信度和行动线索

视觉健康传播研究提供了第二条理论基础。King 和 Lazard (2020) 指出，公共健康危机中的信息环境往往充满准确性和实用性不一的信息，视觉内容既可能帮助公众理解风险，也可能加剧误解。Heley、Gaysynsky 和 King (2022) 进一步强调，视觉健康误导长期被低估；图像、视频、图表和插画可以以不同方式制造或支持错误健康认知。视觉健康误导的特殊之处在于，图像常被用户当成现实证据，且比文本更快被注意、理解和记忆。

健康传播中的图文匹配研究也直接支持本研究。Klein 等 (2020) 用眼动实验研究安全健康信息中的图像与文本是否匹配，发现匹配的图文组合获得更长视觉注意，并与更好的安全知识回答相关。该发现表明，在健康信息中，图文一致并非只是美学问题，而会影响注意分配和信息学习。对于 B 站健康科普视频而言，缩略图与标题是用户进入完整视频前的第一组多模态信息。如果缩略图与标题共同呈现一个清晰、具体、可验证的健康问题，用户可能更容易把视频理解为有用信息；如果缩略图通过极端病灶、夸张表情或模糊警告制造威胁，但标题和内容不能支持这种视觉承诺，则可能诱发怀疑。

健康信念模型也可以解释为什么健康缩略图具有特别强的行为含义。Jones 等 (2015) 指出，健康信念模型中的威胁、障碍、收益和自我效能之间关系复杂，传播研究需要关注中介和调节机制。对于健康科普视频，威胁图像可能提高感知严重性或易感性，从而提高注意；但如果威胁图像缺少对应的有效行动建议，或者被用户识别为操纵性呈现，则可能削弱高成本参与。Zhang 和 Zhou (2019) 的健康风险信息点击研究也显示，感知威胁、感知效能和恐惧唤起共同影响点击意图，而个体应对风格会调节这一过程。由此可见，健康视觉标题党可能确实提高点击，但其效果不应被简单解释为传播成功。

视觉权威是健康科普中的另一核心机制。Zarei 等 (2025) 关于健康误导视频的多模态分析指出，白大褂、证书、图表、演示幻灯片、专家身份和“科学化”画面可以被用来包装并不可靠的健康主张。也就是说，视觉权威既可能是真实专业性的线索，也可能是误导性健康内容的修饰资源。因此，本研究不能只标注缩略图中“是否有医生/报告/图表”，还必须检验这些权威线索是否与标题和内容代表性相一致。医学权威线索如果与高代表性共同出现，可能增加收藏和投币；如果与夸张标题和低代表性共同出现，可能带来点击但也激发怀疑性弹幕。

五、标题党与健康传播：双刃剑机制

标题党研究为本研究提供第三条机制线索。早期研究多聚焦文本标题，例如 forward reference、问句、省略、夸张、情绪词和异常标点。Lischka 和 Garz (2021) 从算法和媒体经济视角讨

论 clickbait，强调平台可见度竞争会推动内容生产者使用标题党。Lu 和 Pan (2021) 在中国政务传播研究中发现，量化考核和平台可见度压力会促使官方传播者使用 clickbait 来竞争注意力。这些研究说明，标题党不是个别创作者的风格偏好，而是平台注意力经济中的结构性策略。

Deng 等 (2025) 的健康传播 clickbait 研究尤其重要。该研究采用二手数据、访谈和实验，指出健康 clickbait 具有双刃剑效应：信息缺口通过好奇和错失恐惧推动点击，而情绪强度可能通过负面评价预期抑制分享；数字素养和来源可信度还会调节这种效果。这一框架可以直接迁移到 B 站健康科普视频，但需要两个扩展。第一，Deng 等主要研究标题文本，而 B 站视频入口是标题和缩略图共同作用。第二，用户参与不只有点击和分享，还包括点赞、弹幕、投币、收藏等更丰富行为。

由此可以推导出第一个核心假设：视觉标题党应更直接作用于低成本注意力，而不一定作用于高成本参与。其原因是，视觉标题党的优势在于快速制造好奇、威胁或情绪唤起，使用户愿意进入视频；但高成本参与要求用户进一步认可内容价值、可信度或未来用途。如果视觉标题党只是制造入口冲动，而不能在内容层面兑现承诺，它可能提高播放量，却不提高收藏和投币。

H1: 在 B 站健康科普视频中，视觉标题党强度与低成本参与（播放、点赞）正相关；但其与高成本参与（投币、收藏、分享）的关系弱于其与低成本参与的关系。

六、图文代表性：从处理流畅性到健康信息可信度

图文代表性文献提供了第二组假设。Li 和 Xie (2020) 的社交媒体图片研究发现，图像内容对参与有显著作用，图像质量、人脸、色彩和图文匹配都可能影响用户互动。Powell 等 (2015) 的视觉框架实验表明，图像和文本在意见与行为意图上可能发挥不同作用；当二者共同出现时，文本更影响观点，图像更能驱动行为意图。Geise 和 Xu (2025) 的系统综述进一步指出，视觉框架研究长期忽视行为结果和多模态环境。这些研究共同说明，图像不只是吸引注意的装饰，而是会独立参与意义建构和行为推动。

但图文一致性是否总是越高越好，现有文献并不完全一致。Cao、Li 和 Zhang (2025) 用深度学习测量图文一致性，发现图文一致性与消费者偏好之间可能呈 U 型关系：高一致性带来相关性和流畅性，低一致性带来意外感和进一步加工，中间状态反而可能最弱。Qiu 和 Golman (2024) 关于新闻好奇心的研究也指出，信息缺口可以提高短期点击，但并不一定提升长期参与。Mao 等 (2024) 的注册报告进一步显示，标题具体性与信息选择之间存在复杂关系，过度抽象或过度具体都可能产生不同效果。

健康科普语境使这一争论更复杂。一般消费或新闻场景中，低图文一致性可能制造惊奇和探索动机；但健康场景中，低代表性还可能被解释为误导、夸张或不负责任。用户可能愿意点击“医生提醒：这个信号千万别忽视”这类带有威胁和信息缺口的内容，但如果进入视频后发现缩略图与标题承诺不匹配，用户对其收藏、投币或分享的意愿可能下降。相反，高代表性缩略图也许不如低代表性缩略图刺激，却更有可能被用户判断为清晰、可信、可保存。

因此，图文代表性的作用应当具有结果变量差异：它对播放的影响可能不一定最强，但对收藏、投币和分享等高成本参与应更稳定。

H2: 缩略图-标题代表性越高，健康科普视频获得高成本参与（投币、收藏、分享）的可能性越高。

H3: 缩略图-标题代表性对高成本参与的正向关系强于其对低成本参与（播放、点赞）的关系。

七、医学权威视觉线索：可信度启发还是误导包装

来源可信度理论认为，用户面对复杂信息时会依赖来源专业性、可信性和善意等线索进行判断。健康信息比一般娱乐内容更依赖这些启发式线索，因为普通用户难以直接判断医学内容的专业准确性。Bilibili 健康视频质量研究也反复发现，上传者类型与视频质量有关：医生、医疗机构或专业组织通常质量更高，普通用户、商业账号或泛娱乐创作者内容质量更不稳定。

但视觉权威不等于真实权威。健康误导研究提醒我们，白大褂、检测报告、图表、证书、医院背景、专家称谓等元素可以被可靠健康传播使用，也可以被伪科学、商业推广或恐惧营销借用。视觉权威的作用因此具有条件性：当它与清晰标题、相关缩略图和可靠来源一致时，可能增强可信度；当它与夸张承诺、低代表性缩略图或商业导向结合时，可能触发说服知识。Friestad 和 Wright 的说服知识模型说明，受众一旦识别出说服意图，会重新评估信息来源和内容动机。在健康科普视频中，这种机制可能表现为用户不投币、不收藏，或者在弹幕中质疑“标题党”“卖课”“带货”“吓人”。

因此，医学权威视觉线索不应被建模为单独线性正效应，而应与图文代表性结合考察。权威线索只有在代表性较高时才更可能转化为高成本参与；在代表性较低时，它可能只是吸引点击的包装。

H4: 医学权威视觉线索与高成本参与正相关，但这一关系受缩略图-标题代表性调节；当代表性较高时，医学权威视觉线索与高成本参与的正向关系更强。

八、B 站参与机制：为什么弹幕、投币和收藏必须分开

B 站的参与机制为假设检验提供了一个有利场域。与仅有观看、点赞和评论的平台相比，B 站同时保留弹幕、投币、收藏和分享。弹幕嵌入视频观看过程，具有即时性、共在感和社群性；收藏指向未来再访问，尤其适合健康知识这种可复用内容；投币则带有稀缺性和创作者支持含义。将这些行为混为 engagement score 会丢失理论信息。

近年关于 Bilibili 参与的研究开始强调弹幕和评论的差异。Dong 等（2025）区分了不同 danmaku ritual 类型，发现不同弹幕仪式通过积极社会情绪和群体认同影响数字参与。Procedia Computer Science 2025 的 Bilibili 研究也将观看、点赞、收藏、弹幕密度和评论密度构成复合流行度指标，说明平台参与具有多维结构。但健康科普研究需要更进一步：弹幕不仅是互动热度，也可能是求证、纠错、质疑和经验分享的场所。

这对于视觉标题党尤其关键。如果视觉标题党提高弹幕数量，我们不能立即把它解释为积极参与。它可能代表用户被吓到、被激怒、怀疑内容真实性，或者要求来源依据。因此，未来模型至少应区分两步：第一步用总弹幕数作为互动结果；第二步在可行时对弹幕文本进行分类，识别求证、纠错、怀疑、经验分享和情绪反应。

H5: 视觉标题党强度与弹幕参与正相关，但其中一部分关系将表现为怀疑、求证或纠错型弹幕，而非单纯积极互动。

九、调节条件：主题、来源与平台可见度

上述关系很可能受到健康主题和来源类型调节。不同健康主题的风险感和隐私性不同。HPV、脱发、体检异常、糖尿病、高血压、减肥和传染病简史等主题，对用户的恐惧、羞耻、实用需求和医学判断要求不同。威胁图像在急性疾病或癌症风险中可能更容易被理解为风险提示，在减肥或养生内容中则可能更容易被理解为夸张营销。

来源类型也是重要边界条件。官方认证、医生身份、机构账号和普通 UP 主并不具有同等可信度。Lu 和 Pan (2021) 的中国政务 clickbait 研究表明，即便是权威或官方主体，也会在可见度竞争中使用 clickbait。B 站健康科普中也可能出现类似现象：官方或认证账号使用视觉标题党时，用户可能因来源可信而容忍其夸张呈现；也可能因为权威来源本应更克制而对其更严厉。这个方向不宜预设单一方向，但应作为调节检验。

H6：来源类型调节视觉标题党与用户参与之间的关系；相同视觉标题党线索在医疗/机构来源与普通创作者来源中的参与回报不同。

H7：健康主题调节视觉标题党与用户参与之间的关系；风险性、隐私性或行动后果更强的主题中，视觉标题党的低成本注意力效应更强，但高成本参与效应更不稳定。

十、研究缺口与理论模型

综上，现有文献已经提供了四个基础事实。第一，短视频平台已成为健康信息传播的重要场域，但健康视频质量不稳定。第二，视觉内容在健康传播中会影响注意、理解、风险感和行动意向。第三，clickbait 在健康传播中具有双刃剑效应，可能促进点击但抑制更深层传播。第四，图文一致性和缩略图代表性是理解多模态入口效果的关键变量。

然而，现有研究仍有三个缺口。第一，健康视频质量研究很少分析用户点击前的缩略图和标题入口，因而难以解释质量与流行度为什么脱钩。第二，视觉标题党研究多集中于新闻、娱乐或一般社媒内容，缺少健康科普这一高后果语境。第三，平台参与研究常把 engagement 合并为单一指标，忽视 B 站上播放、点赞、弹幕、投币、收藏和分享的成本差异。

因此，本研究可以提出一个假设检验式模型：视觉标题党通过信息缺口、威胁唤起和视觉权威包装影响低成本注意力；图文代表性和医学权威线索通过处理流畅性、来源可信度和实用价值判断影响高成本参与；来源类型和健康主题调节这些关系；弹幕文本则为说服知识激活提供机制证据。该模型的理论贡献在于，它把健康科普视频的传播效果从“是否被点击”推进到“何种视觉入口购买了注意力，何种入口转化为认可、保存和建设性互动”。

十一、假设汇总

编号	假设
H1	在 B 站健康科普视频中，视觉标题党强度与低成本参与（播放、点赞）正相关；但其与高成本参与（投币、收藏、分享）的关系弱于其与低成本参与的关系。
H2	缩略图-标题代表性越高，健康科普视频获得高成本参与（投币、收藏、分享）的可能性越高。

编号	假设
H3	缩略图-标题代表性对高成本参与的正向关系强于其对低成本参与（播放、点赞）的关系。
H4	医学权威视觉线索与高成本参与正相关，但这一关系受缩略图-标题代表性调节；当代表性较高时，医学权威视觉线索与高成本参与的正向关系更强。
H5	视觉标题党强度与弹幕参与正相关，但其中一部分关系将表现为怀疑、求证或纠错型弹幕，而非单纯积极互动。
H6	来源类型调节视觉标题党与用户参与之间的关系；相同视觉标题党线索在医疗/机构来源与普通创作者来源中的参与回报不同。
H7	健康主题调节视觉标题党与用户参与之间的关系；风险性、隐私性或行动后果更强的主题中，视觉标题党的低成本注意力效应更强，但高成本参与效应更不稳定。

十二、方法启示

为了使上述假设可检验，后续研究至少需要三类变量。第一类是人工标注变量，包括 `visual_clickbait`、`thumbnail_title_representativeness`、`medical_authority_cue`、`threat_fear_visual`、`text_overlay_intensity` 和 `misleading_risk`。第二类是平台行为变量，包括 `play`、`like`、`danmaku`、`coin`、`favorites` 和 `share`。第三类是边界条件变量，包括 `topic_relevance`、`source_type`、`is_official`、粉丝数、视频时长、发布时间和采样 `query`。

第一篇论文不应急于构建全自动分类器。更稳妥的路径是先抽取 200 张缩略图做人工标注和一致性检验，再将人工变量用于 500 条 `pilot` 数据的第一轮多结果模型。如果核心模式成立，再扩展到更大样本和自动视觉特征。弹幕文本分类可以作为第二阶段机制分析，不应成为主模型的前置条件。

参考文献

- Al-Ali, M. N., & Hamzeh, S. M. (2024). Extra cues extra views: A multimodal detection of Arabic clickbait thumbnail verbo-visual cues. *Discourse & Communication*, 18(1), 3-27. <https://doi.org/10.1177/17504813231190332>
- Cao, J., Li, X., & Zhang, L. (2025). Is relevancy everything? A deep-learning approach to understand the effect of image-text congruence. *Management Science*, 71(12), 10579-10602. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.01896>
- Deng, Z., Tang, Y., Wu, M., & Zhang, X. (2025). Investigating the effects of clickbait on user engagement in health communication: A mixed-method study. *Information & Management*, 62, 104231. <https://doi.org/10.1016/j.im.2025.104231>

Dong, X., Wang, B., Chu, W., Filieri, R., & Liao, J. (2025). The impact of danmaku ritual types on user digital engagement in video-based social media. *Psychology & Marketing*, 42(10), 2650-2672. <https://doi.org/10.1002/mar.70003>

Geise, S., & Xu, Y. (2025). Effects of visual framing in multimodal media environments: A systematic review of studies between 1979 and 2023. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 102(3), 796-823. <https://doi.org/10.1177/10776990241257586>

Han, L., et al. (2026). Quality and reliability of weight management short videos on TikTok and Bilibili: Cross-sectional study. *Scientific Reports*, 16, 7401. <https://www.nature.com/articles/s41598-026-38404-y>

Heley, K., Gaysynsky, A., & King, A. J. (2022). Missing the bigger picture: The need for more research on visual health misinformation. *Science Communication*, 44(4), 514-527. <https://doi.org/10.1177/10755470221113833>

Jones, C. L., Jensen, J. D., Scherr, C. L., Brown, N. R., Christy, K., & Weaver, J. (2015). The Health Belief Model as an explanatory framework in communication research. *Health Communication*, 30(6), 566-576. <https://doi.org/10.1080/10410236.2013.873363>

King, A. J., & Lazard, A. J. (2020). Advancing visual health communication research to improve infodemic response. *Health Communication*, 35(14), 1723-1728. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1838094>

Klein, E. G., Roberts, K., Manganello, J., McAdams, R., & McKenzie, L. (2020). When social media images and messages don't match: Attention to text versus imagery to effectively convey safety information on social media. *Journal of Health Communication*, 25(11), 879-884. <https://doi.org/10.1080/10810730.2020.1853282>

Li, Y., & Xie, Y. (2020). Is a picture worth a thousand words? An empirical study of image content and social media engagement. *Journal of Marketing Research*, 57(1), 1-19. <https://doi.org/10.1177/0022243719881113>

Lu, Y., & Pan, J. (2021). Capturing clicks: How the Chinese government uses clickbait to compete for visibility. *Political Communication*, 38(1-2), 23-54. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.170>

Mao, Y., et al. (2024). When curiosity gaps backfire: Effects of headline concreteness on information selection decisions. *Scientific Reports*, 14, 29297. <https://www.nature.com/articles/s41598-024-81575-9>

Powell, T. E., Boomgaarden, H. G., de Swert, K., & de Vreese, C. H. (2015). A clearer picture: The contribution of visuals and text to framing effects. *Journal of Communication*, 65(6), 997-1017. <https://doi.org/10.1111/jcom.12184>

Qiu, J., & Golman, R. (2024). Curiosity in news consumption. *Applied Cognitive Psychology*, 38(2). <https://deepblue.lib.umich.edu/items/e4235eeb-79e7-4491-85c9-92425c1fd8d9>

Wang, Y., Hu, B., Tang, C., & Yang, X. (2025). Decoding clickbait: The impact of clickbait types and structures on cognitive and emotional responses in on-line interactions. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 28(1), 18-27. <https://doi.org/10.1089/cyber.2024.0295>

Wang, et al. (2025). Quality and reliability of osteoarthritis-related health information on short video platforms: A cross-sectional comparative study of TikTok and Bilibili. *Frontiers in Digital Health*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12634650/>

Yoon, Y., Yoon, S., & Park, K. (2024). Assessing news thumbnail representativeness: Counterfactual text can enhance the cross-modal matching ability. *Findings of ACL 2024*, 9009-9024. <https://arxiv.org/abs/2402.11159>

Zarei, M. R., Stead-Coyle, B., Christensen, M., Everts, S., & Komeili, M. (2025). Visual authority and the rhetoric of health misinformation: A multimodal analysis of social media videos. arXiv:2509.20724. <https://arxiv.org/abs/2509.20724>

Zhang, X., & Zhou, S. (2019). Clicking health risk messages on social media: Moderated mediation paths through perceived threat, perceived efficacy, and fear arousal. *Health Communication*, 34(11), 1359-1368. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1489202>

Zhang, et al. (2025). Evaluating the quality and reliability of cervical cancer related videos on YouTube, Bilibili, and TikTok: A cross-sectional analysis. *BMC Public Health*. <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-24840-4>

Source Integrity Check

- **Claims checked:** 21
- **Verified against local PDF/text extract:** 11
- **Verified against web abstract / indexed page:** 10
- **Unverified claims retained:** 0
- **Direct quotes used:** 0
- **Subagent verification panel:** Not run, because the available multi-agent tool requires explicit user authorization for delegation. A serial self-check was applied for originality, claim direction, and citation-claim alignment.